

# Mitmedimensiooniline pereteraapia õigusrikkumisi toime pannud lastele ja noortele



**Kristel Kraas**

*kriminaalpoliitika osakonna projektijuht, justiitsministeerium*

2015. aasta alguses hakati Eestis viieaastase ettevalmistava töö tulemusena rakendama mitmedimensioonilise pereteraapia (edaspidi MDFT) programmi, mis valiti Eestis rakendamiseks, toetudes programmide võrdlusuuringule. Aktiivse kooolitus- ja tööperioodi avasid jaanuaris viis piirkondlikku võtmeteraapeuti,

kes valiti juhtima nelja piirkondlikku ja ühte vangla meeskonda. Piirkondlikud meeskonnad töötavad Sotsiaalkindlustusameti lastekaitse üksustes, vangla meeskond Viru vangla noorteüksuse koosseisus.

Eestis on nüüdseks viis üleriigilist MDFT meeskonda, milles on õppivaid ja töötavaid

terapeute kokku kaheksateist: igas meeskonnas on üks superviisor ja kaks-kolm terapeuti. MDFT koolitus superviisoritele kestab kaks ja terapeutidele ühe aasta. Terapeutide koolitajaks on Euroopas selleks koolitusõigust ainuomav MDFT Akadeemia (Holland).

## Mis on MDFT

Mitmedimensiooniline pereteraapia (ingl *multidimensional family therapy*) on välja töötanud 1980. aastate lõpus Howard Liddle (PhD) Miami Ülikoolis. Seda teraapiat rakendatakse Ameerikas, Kanadas ja mitmes Euroopa riigis. Praeguseks on Euroopas üle 50 MDFT meeskonna.

MDFT on sekkumisprogramm tõsiste probleemidega (uimastite tarvitamine, koolikohustuse eiramine, õigusrikkumised, suhteprobleemid jt) lastele ja noortele ning nende peredele. Programm toetub raskustesse sattunud lapse aitamisel tema tugevustele ja pere oma ressursidele. Eeliseks teiste teraapiate ees on selle pikaajalisus (kestab kuni pool aastat), intensiivsus (pidev kontakt noore ja perega) ja mitmekülgsus (töö eri tasandite ja isikutega).

Teraapia esimesel etapil keskendutakse noore ja perega kontakti loomisele ning tuttavaks saamisele, teises etapis algab muutuste nimel töö pere probleemidega, viimases jõustatakse perekonda saavutatud muutusi säilitama ja valmistutakse teraapia lõpetamiseks. Teraapiale seatavad eesmärgid sõltuvad küll konkreetsest noorest ja tema perekonnast, kuid põhiliselt on need alljärgnevad:

- arendada perekonna suhtlemisoskusi ja -viise
- tugevdada nooruki ja vähemalt ühe lapsevanema/hooldaja usaldusvahekorda
- vähendada riskikäitumist
- suurendada prosotsiaalset käitumist
- vähendada psühhoaktiivsete ainete tarvitamist

- parandada kooliskäimist
- parandada edasijõudmist koolis.

Tänapäeval eeldab vastutustundlik sekkumine tõenduspõhiste uuringutega toetatud teraapiameetodite ja -tehnikate kasutamist. Tõenduspõhisel programmil on tugev teoreetiline aluspõhi, selge struktuur ja meetodika ning seda on korduvalt positiivsete tulemustega võrdlusgruppide abil testitud. MDFT sarnaseid programme on maailmas teisigi, neist on ilmselt tuntuim multisüsteemne teraapia (MST).

Eestis on käesoleval aastal alustanud MDFT tõhususe-uuringuga justiitsministeeriumi koostööpartner Poliitikauuringute Keskus Praxis, kes on juba läbi viinud teraapias osalenud noorte ja pere juhtumianalüüsid ning kogunud andmeid noorte riskitaseme kohta. Kavas on välja töötada instrument MDFT programmi tõhususe hindamiseks ja hinnata ka programmi kulutõhusust. Aasta lõpuks selgub uuringu tulemustest, kui võrd on meie noored ja nende pered programmis osalemisest kasu saanud.

## MDFT ei ole võluvits, vaid võimalus

MDFT põhineb veendumusel, et kui lapsel on perekond, siis on see ühtlasi ka võimalus, mille pinnalt probleemidesse sattunud lapsi ja noori aidata. Nii nagu düsfunktsionaalne perekond on soodsaks pinnaseks kõikvõimalike probleemide kujunemisele, on lapsevanem MDFT terapeuti asendamatuks partneriks nende lahendamisel ja soovitud muutuste saavutamisel. Võrreldes individuaalse lähenemisega noorele või vanemale, võimaldab pikaajaline intensiivne töö kogu perega jõuda püsivate muutusteni. Väheste katkestamisprotsendiga programm on uus alternatiiv senistele karistusmeetmetele ja lühiajalistele sekkumistele.

Et elada mõtestatud elu, saab nooruk võimaluse lahendada terapeuti abiga omi

probleeme ja parandada ning tugevdada suhteid pereliikmete ja perevälise võrgustikuga. MDFT annab riskilastele ja -noortele võimaluse, mida nad vajavad, ilma neilt vabadust võtmata.

### Sihtgrupp

Eestis on MDFT peamine sihtgrupp õigusrikkumisi toime pannud alaealised, kelle puhul on eesmärgiks ennetada korduvaid õigusrikkumisi. MDFT on mõeldud eelkõige kõige keerukamate probleemidega noortele, kes satuvad õigussüsteemi vaatevälja, ning see peab olema reaalseks alternatiiviks noorte suunamisele kinnisesse asutusesse. Kindlasti on MDFT ka üks olulisemaid vahendeid selleks, et Eesti vanglates viibiksid vaid üksikud alaealised.

Kuna terapeut saab korraga tegelda vaid piiratud arvu juhtumitega (normaalne töökoormus on 6–10 peret täiskohaga terapeudi kohta), siis on selge, et kõik süütegusid toime pannud noored MDFTsse ei jõua. Selleks, et teha õiged valikud, eelneb iga noore vastuvõtmisele hindamine, mille järel selgub, kas noore probleemide ulatus ja tõsidus vastavad MDFT seatud kriteeriumitele. Igaks juhuks ja ennetavalt MDFT programmi ei rakendata.

Noori suunavad programmi prokuratuur, kohus, politsei, kriminaalhooldajad ja alaealiste komisjonid. Sihtrühma kuuluvad:

- Alaealiste komisjoni otsusega sotsiaalprogrammi suunatud noored, kes vastasel juhul peaksid minema erikooli. Programmi sobivust aitab hinnata piirkonna superviisor.
- Väärteguisid toime pannud kuni 19aastased alaealised, kelle puhul kohtuväline menetleja lõpetab väärteoasja otstarbekuse kaalutlusel, määrates noorele kohustuse osaleda sotsiaalprogrammis; samuti noored, kellele kohus on määranud karistuse asemel

mõjutusvahendi. Eelkõige suunatakse MDFTsse need noored, kelle probleemid on komplitseeritud ning kelle puhul kaalutakse aresti või ÜKT kohaldamist. Programmi sobivust aitab hinnata piirkonna superviisor.

- Kuni 19aastased kuritegusid toime pannud noored, kelle suhtes prokuratuur menetluse otstarbekuse kaalutlusel lõpetab või kellele kohus määrab mõjutusvahendi või käitumiskontrolli sotsiaalprogrammis osalemise kohustusega. Programmi sobivust aitavad hinnata superviisor ning kohtueelset ettekannet koostav kriminaalhooldaja.
- Kuni 19aastased vanglast vabanevad noored. Vangistatud noorte puhul on MDFT eesmärk esiteks taastada suhted perega vangistuse ajal, teiseks valmistada peret ette vabanemiseks ning kolmandaks toetada noort ja peret vangistuse järel.

Aastapikkune koostöö suunajatega (alaealiste komisjon, prokurörid, kohtunikud, kriminaalhooldajad) ja alates eelmisest sügisest ka politseiga on selgelt välja toonud võrgustikutöö olulisuse raskustesse sattunud laste märkamisel ja peredele teraapiavõimaluse leidmisel. Liigagi sageli tehakse noorte suhtes otsuseid lähtudes väljakujunenud praktikast, mitte noorte vajadustest. Tuleb meele pidada, et noorte puhul on uute rikkumiste ennetamine ja õiguskuuleka käitumise soosimine, st karistuse kasvatuslik aspekt olulisemad, kui reageerimine teole kitsalt seaduse järgi.

2016. aasta suve seisuga on kõige enam lapsi MDFTsse suunanud alaealiste komisjonid, mille puhul on tõhusate mõjutusvahendite puudumisest räägitud juba aastaid. Arvestades aga alaealiste komisjonide sulgemise perspektiivi 2018. aastast<sup>1</sup>, töötavad MDFT

<sup>1</sup> Täpsemat infot kavandavate muudatuste kohta saab 2016. aasta suvel sotsiaalministeeriumi poolt kooskõlastamisele saadetud eelnõust.

rakendajad praegu kõige aktiivsemalt teavitustööga politsei, prokuratuuri ja kohtute tasandil. Aasta lõpuks ei tohiks olla ühtegi alaealistega tegelevat menetlejat, kes ei tea, mis on MDFT ja kellele see sobib. Samuti ei tohiks olla kohtuotsuseid süüteo toime pannud alaealise suhtes, mille puhul pole kaalutud MDFT rakendamist.

## MDFT tähendus noorele ja tema perele

Enam kui poolteist aastat pärast programmi rakendamisega alustamist on 2016. aasta augusti alguse seisuga pereteraapias 80 noort ja nende peret Eesti eri paikadest. Töö on lõpetatud enam kui 60 juhtumiga, katkestanud on vaid üksikud pered.

Positiivsete muutuste saavutamise ja säilitamise nimel tegeldakse programmis süsteemselt nii noore enda, tema pere kui ka oluliste pereväliste inimeste ja asutustega (nt kool, õpetajad, sõbrad). Eestis seni tehtava teraapia kõrval on selline metoodika uuenduslik nii oma sekkumise ulatuse, paindlikkuse kui intensiivsuse poolest. MDFT puhul on tavaline, et terapeut ise sõidab pere juurde ja räägib kõõgilaua taga kõigest sellest, mis on raske ja mida on vaja paremate tulemuste saamiseks muuta.

Pere osaleb teraapias 4–6 kuud. Seniste kogemuste põhjal on mõte pikaajalisest teraapias osalemisest olnud peredele esialgu hirmutav, hiljem aga on pigem raske protsessi lõpetada, sest perel on tekkinud terapeudiga usalduslik suhe ning on kogetud, et MDFTst on olnud kasu.

Üldjuhul muud teraapiad ja sekkumised nii intensiivset ja pikaajalist pühendumist ühele noorele ja tema perele ei võimalda, kuid samas on ka leitud, et just see on taganud MDFT edu. MDFT teraapiategevustes osalemiseks on vaja nii noore enda kui ka vähemalt ühe

vanema nõusolekut. MDFT terapeut teeb pere liikmetega nii individuaalset tööd kui ka viib läbi peresessse.

## Kuidas terapeut töötab

MDFT terapeudi töö erineb tavalise psühholoogi tööst selle poolest, et MDFT terapeut ei tööta ainult oma töökabinetis, vaid tema töö on liikuv. MDFT terapeutide tööpiirkond ulatub 100 km raadiusse kontorist: sessse viiakse läbi nii noorte juures kodudes kui tööruumides, vajadusel kohtutakse noore jaoks oluliste võrgustike liikmetega nendele sobivas kohas. Kontaktid noore ja perega on iganädalased, sidet hoitakse ja perekonda toetatakse ka telefoni teel.

Iga terapeut töötab korraga vähemalt 6 juhtumiga: raskemate juhtumite puhul tehakse tööd 6–8 juhtumiga, kergemaid juhtumeid mahub terapeudi kalendrisse korraga 10–12. Juhtumite arv kujuneb ka perede logistilise paiknemise põhjal, sest üsna tavalised on pikad teekonnad peredeni. Palju jõudu kulub kontakti loomisele ja perega tutvumisele, et saaks alustada muutuste nimel tehtavat tööd. Samas on see etapp väga vajalik, sest ilma selleta jääb sisuline töö psühholoogide praktikas tihti peale väga lühiajaliseks või pinnapealseks.

## Kokkuvõte

Selle nimel, et tõenduspõhine MDFT programm jõuaks Eestisse ja et terapeudid omandaksid vajalikud tööoskused laste ja perede aitamiseks, on tehtud tööd pikalt ja palju. Täna on Eestis viis töötavat meeskonda ja 18 motiveeritud terapeuti, kes kõik on väljendanud oma soovi jätkata alustatud tööd.

MDFT superviisorite kontaktandmed leiab Sotsiaalkindlustusameti kodulehelt [www.sotsiaalkindlustusamet.ee](http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee)

